Tribunal de Justiça de Pernambuco
Poder Judiciário
Seção A da 5ª Vara Cível da Capital

Avenida Desembargador Guerra Barreto - Fórum do Recife, S/N, Ilha Joana Bezerra, RECIFE - PE - CEP: 50080-900 - F: (81) 31810381

Processo nº **0095948-29.2023.8.17.2001**

ESPÓLIO - REQUERENTE: JOSE PAULO BARBOSA NEVES JUNIOR
REPRESENTANTE: DANIELE BATISTA DE SOUZA NEVES

RÉU: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

SENTENÇA

Vistos e examinados etc.

ESPÓLIO DE JOSÉ PAULO BARBOSA NEVES JUNIOR, na pessoa da inventariante, Sra. Daniele Batista de Souza Neves, conforme sentença de habilitação, por meio de advogado regularmente habilitado, propôs a presente **AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C DANOS MORAIS** em face de HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA., igualmente qualificada, narrando, a tanto, que é vinculado a contrato de plano de saúde firmado com a ré, e que em meados de junho de 2023 foi diagnosticado com câncer gástrico localmente avançado, chegando a estado grave.

Relata o autor, que para seu tratamento farmacológico foi indicado o remédio Docetaxel associado com Oxiplatina, seguido de Laparotomia Exploratória.

Em seu relato, o autor noticia que o referido tratamento se mostrou ineficaz.

Pontua que diante do novo quadro apresentado, buscou auxílio de uma segunda opinião médica, e naquela consulta lhe foi informado que o melhor tratamento a ser realizado seriam os remédios Folfox + Nivolumabe, posto que é comprovado o aumento de sobrevida global de que ele é capaz de proporcionar ao paciente.

Argumenta ainda em sua inicial, que como os sintomas dele, autor, estavam muito presentes e graves, iniciou o procedimento para solicitar o novo esquema de tratamento quimioterápico mencionado pelo novo médico oncológico, contudo, o plano réu

negou duas vezes, sob justificativa de que o demandante não se enquadra nos critérios do estudo, assim como a medicação não possui cobertura contratual ou faz parte do rol de procedimentos e eventos da ANS.

Expôs o autor ainda em sua peça inicial, que existe estudo científico que demonstra que a associação dos últimos remédios prescritos reduziu o risco de progressão de doença ou morte em 32%.

Finalmente em sua inicial o autor diz que a conduta da operadora ré foi abusiva, ao excluir de sua cobertura o tratamento, tendo em vista que o referido tratamento não é fundamentado em estudos científicos.

Aduz, ainda, que cientificada para autorizar o procedimento, a demandada não autorizou, sob justificativa de que aquele procedimento não era acobertado pelo plano, fato esse que lhe impulsionou a buscar a prestação jurisdicional para ver solucionada a presente querela.

Após a análise do juízo, sobre a possibilidade da concessão da tutela, foi proferida decisão deferindo, cujo teor se encontra no ID 142306884, determinando o fornecimento das referidas medicações.

Devidamente citada, a ré ofertou sua contestação, onde em síntese diz que embora o medicamento NIVOLUMAB tenha registro na Anvisa, a indicação do tratamento solicitado não está adequada ao estudo pivotal que embasou a bula da referida medicação.

Ressalta a que a medicação sofre exclusão de cobertura por ser considerada experimental, o que o caracteriza de uso off label, e que inexistindo dados concretos acerca das principais medidas de eficácia, impossível assentar entendimento quanto à imprescindibilidade do fármaco, devendo ser aplicado o Incidente de Recurso Repetitivo – IRC TEMA:106 DO STJ, o que torna vinculante a decisão.

Repousa nos autos, ID 15089923, Pedido de Extensão dos Efeitos da Tutela de Urgência para fazer alteração na medicação do autor em face da demora no fornecimento do fármaco, indicando o médico assistente desta vez o medicamento RAMUCIRUMABE 8mg, combinado com o PACLITAXEL, ato contínuo, o juízo determina a ouvida da parte demandada.

Comunicação do falecimento do autor da ação no ID 157470619.

Ato contínuo, a inventariante se habilita nos autos. Sobreveio a sentença de habilitação, cujo teor se encontra no ID 184367076.

Intimadas as partes sobre a necessidade de produção de novas provas, a parte demandada pede a extinção do feito por perda de objeto.

Requer a improcedência de todos os pedidos formulados na ação.

Vieram-me os autos conclusos.

RELATADO. DECIDO.

A presente hipótese dispensa a produção de novas provas, comportando julgamento no estado em que se encontra, facultando-se a este magistrado proferir sentença de imediato, tudo nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC/2015.

Pois bem, de logo anuncio o entendimento de que diante da natureza de adesão do contrato de plano de saúde é aplicável a súmula 608 do STJ. "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de Plano de Saúde, salvo os administrados por entidade de autogestão" e a mesma Corte também firmou entendimento no sentido de que embora não se aplique as disposições da lei 9.656/98 aos contratos celebrados antes de sua vigência e não adaptados, a análise de eventual abusividade pode ser aferida à luz do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, basta pesquisar o AgInt no AREs 1925946/SP, 4 URMA, dJe 01/12/2021. Dito isso, passo, portanto, a auferir se houve abusividade na conduta da operadora ré.

A controvérsia diz respeito à cobertura pelo plano de saúde réu em relação à cobertura de tratamento oncológico realizado pelos fármacos Folfox e Nivolumabe indicados para câncer gástrico em sua forma grave.

Encontrava-se o então autor acometido de doença grave, sendo usado para solucionar tal quadro remédios tradicionais, contudo, o autor entrou em processo refratário a diversos medicamentos, conforme relato do médico assistente, pois não obteve bons resultados, sendo indicados pelo novo médico os remédios Folox e Nivolumabe, no entanto, antes de qualquer uso, o autor entrou em óbito.

Pois bem, com o falecimento do autor, o tema de logo deverá ser enfrentado pelo magistrado, chamo atenção para o fato de que já foram realizadas as habilitações e de logo enfrentarei o novo fato do autor ter falecido durante o transcorrer da ação. Sem mais delongas, entendo que o processo deve prosseguir, contudo, só em face do pedido dos danos morais, devendo ser declarado extinto em relação à obrigação de fazer, qual seja, ao fornecimento de medicamentos, pois entendo que, com o falecimento do autor da ação, e tratando-se de ação personalíssima, impõe a extinção do feito. O pleito relativo ao fornecimento de medicamento oncológico direcionado a plano de saúde constitui direito personalíssimo do beneficiário, não se admitindo, assim, a sucessão processual pelo falecimento do doente quanto à obrigação de fazer.

Dito isso, remanesce a verificação do segundo pedido contido na inicial, qual seja, Dano Moral, o que exige desse magistrado a verificação da conduta da demandada para averiguar se foi lícita ou não quando negou o tratamento.

Vamos aos fatos e ao Direito. Pois bem, a defesa, na sua peça de bloqueio, insiste na tese de que não estaria obrigada a fornecer os medicamentos, uma vez que esses seriam tratamento OFF LABEL, ou seja, experimental. Essa é a tese central da defesa que o autor se contrapõe.

Esse é o limite da lide. Averiguar se a operadora de saúde estaria obrigada a custear tratamento do autor ou os remédios chamados Off Label que foram indicados pelo médico assistente porque a medicação tradicional se mostrou ineficiente.

Pois bem, as circunstâncias e provas havidas ao processo apontavam de que o quadro de saúde do autor era gravíssimo, sendo ele portador, na ocasião, de enfermidade severa, que caso não fosse atacado de imediato, segundo o médico assistente, poderia levá-lo a óbito. Os remédios anteriormente indicados se mostraram ineficientes, segundo o médico assistente, que prescreveu novos fármacos, contudo, estes são os chamados de Off LABEL, mas que, segundo sua ótica, poderia ter levado o demandante a uma sobrevida maior.

Consta nos autos que o requerente se encontrava em tratamento da enfermidade, durante certo período, e que todas as tentativas realizadas com medicamentos tradicionais ministrados não contiveram o grande mal, ou seja, a doença avassaladora que o acometeu, levando-se em conta que não se obteve o sucesso desejado. O autor, com os remédios tradicionais, nunca alcançou a sua estabilidade do processo devastador da doença, nem tampouco a regressão dos sintomas.

O certo e recerto é que o médico especialista prescreveu o uso de um novo tratamento, novo protocolo, Folfox com Nivolumabe, baseado no estudo CHECMATE-649, que comprovou melhores resultados (sobrevida global) aprovado pela ANVISA. O plano de saúde, no entanto, não autorizou o seu fornecimento, sob a alegação de que o procedimento, seria off label, não estando contido na ANS, e ainda estaria afastada a obrigatoriedade de sua aplicabilidade pelo último repetitivo, o que lhe daria legitimidade e albergado para negar o fornecimento.

A conduta da operadora em negar autorização para o tratamento revestiu-se de caráter abusivo e ilegal, não merecendo prosperar, devendo ser afastada, em consequência, e declarada sua abusividade.

Como se sabe, e o que é albergado pelos precedentes dos mais diversos Tribunais, é que o médico que acompanha o enfermo é o que mais tem condições de avaliar com o cuidado necessário o seu quadro clínico, a doença e os sintomas que dela decorrem, prescrevendo o tratamento mais adequado para a completa cura da enfermidade ou, ao menos, para a redução dos seus efeitos nefastos. O plano de saúde não pode se sobrepor à indicação do profissional, negando o tratamento específico e detalhadamente prescrito para doença terminal de câncer.

Ainda que havendo cláusula limitativa de cobertura desse tipo de tratamento, o plano não pode se negar a autorizá-lo, se o médico do paciente indicou o uso e afirmou ser ele o mais adequado ao tratamento da doença. A cláusula limitativa, neste caso, torna-se abusiva, eivada de nulidade, podendo ser declarada nula de pleno direito, sobretudo, diante das permissões contidas no artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor.

Nessa senda, a jurisprudência do STJ é no sentido de que, ainda que admitida a possibilidade do contrato de plano de saúde conter cláusulas limitativas dos direitos do consumidor (desde que escritas com destaque, permitindo imediata e fácil compreensão, nos termos do §4º do artigo 54 do Código Consumerista), revela-se abusivo o preceito excludente do custeio do medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do beneficiário, ainda que ministrado em ambiente domiciliar e que seja Off Label, principalmente quando o fármaco é indicado para tratamento oncológico. Ante a comprovação efetiva da real necessidade e eficácia do tratamento, a associação de medicamentos indicada pelo médico especialista, excepcionalmente, a seguradora/operadora deve custeá-lo em respeito ao direito à maior sobrevida com melhor qualidade de vida do paciente e à função social do contrato. Outrossim, há previsão de cobertura para o tratamento da doença na avença celebrada entre as partes em litígio, não podendo haver negativa quanto à forma de prestação desse tratamento ao paciente, sob pena de violação ao objeto do contrato de assistência à saúde e à vida do segurado.

Sobre o tema, vejamos os julgados dos Tribunais Superiores:

> *RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. USO "OFF-LABEL". EDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE DOENÇA ONCOLÓGICA. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto por POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS contra decisão que não admitiu o recurso especial, com base no art. 105, III, a e c, da Constituição Federal, desafiando acórdão assim ementado (e-STJ, fls. 1.391-1.392): APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO/SEGURO DE SAÚDE. POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS. AUTOGESTÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. HERCEPTIN E HALAVEN. INDICAÇÃO MÉDICA. NEGATIVA DE COBERTURA. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO DO STJ. OVERRULING. SUBVERSÃO DA FUNÇÃO SOCIAL. CASO CONCRETO. ASSOCIAÇÃO DOS MEDICAMENTOS. OFF LABEL. CARCINOMA DE MAMA METASTÁTICO PARA PULMÕES E FÍGADO. NATJUS. PARECER. EFICÁCIA. REGISTRO. ANVISA. TRATAMENTOS ANTERIORES. INEFICÁCIA. PROGRESSÃO DA DOENÇA. RISCO. CUSTEIO DO TRATAMENTO.*

CABIMENTO. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão (STJ, Súmula 608). 2. Embora a jurisprudência tenha, por anos, considerado o rol de procedimentos e eventos em saúde estabelecido por resolução normativa pela ANS meramente exemplificativo, o STJ mudou seu entendimento (Overruling) e concluiu que o rol é taxativo: REsp 1733013/PR, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe 20/02/2020. Depois, a Segunda Seção ao apreciar os EREsps nº 1.886.926/SP e 1.889.704/SP passou a considerá-lo como exemplificativo condicionado.

3. Com a edição da Lei nº 14.454/2022, os planos e seguros de saúde foram novamente obrigados a cobrir tratamentos que não estejam no rol de procedimento e eventos em saúde da ANS, retomando o seu caráter exemplificativo. ***4. Embora a operadora defenda que não tem a obrigação de oferecer tratamentos não previstos no rol da ANS, deve custeá-los em favor da contratante para o aumento da sobrevida e melhora das condições de vida, tendo em vista tratar-se de doença incurável, em respeito à função social do contrato e em atendimento ao disposto na Lei nº 14.454/2022, quando forem demonstrados: (a) risco notório à sua integridade física e/ou psicológica, caso não realizada a terapêutica; (b) real necessidade do procedimento; (c) sua eficácia; (d) que é o melhor tratamento para a mazela apresentada e (e) a inadequação de eventual tratamento convencional e/ou mais barato.*** *5.* ***O uso off label de fármacos registrados na ANVISA não altera o dever de fornecê-los, sob pena de caracterizar ingerência indevida na ciência médica e prejuízo ao doente. Precedente STJ.*** *6. Ante a comprovação efetiva da real necessidade e eficácia do tratamento a associação de medicamentos indicada pelo médico especialista, excepcionalmente, a seguradora/operadora deve custeá-lo em respeito ao direito à maior sobrevida com melhor qualidade de vida da paciente e à função social do contrato. Outrossim, há previsão de cobertura para o tratamento da doença na avença celebrada entre as partes em litígio, não podendo haver negativa quanto à forma de prestação desse tratamento ao paciente, sob pena de violação ao objeto do contrato de assistência à saúde e à vida do segurado.* RECURSO ESPECIAL Nº 2174659 - DF (2024/0377448-5)

Negar o custeio de tratamento administrável equivaleria, em última análise, a negar cobertura ao tratamento de doença que integra o âmbito da cobertura contratada.

Dito isso, entendo que a recusa foi injustificada, por parte da operadora do plano de saúde, do custeio do medicamento para tratamento adequado da doença oncológica que acometeu a parte autora.

Com efeito, acerca do fornecimento de medicamento de uso experimental, a Segunda Seção do STJ, em julgado submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de inexistir obrigação para a operadora de plano de saúde custear medicamentos importados, desprovidos de registro na Anvisa, **ressalvando que, após a regularização do referido registro, não mais persistiria o direito da seguradora em recusar a cobertura do tratamento medicamentoso indicado pelo médico do paciente/segurado.**

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. TRATAMENTO DE CÂNCER. RECUSA DE COBERTURA INDEVIDA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA.
1. Cuida-se, na origem, de ação de obrigação de fazer, visando o fornecimento do medicamento succinato de ribociclibe (Kisqali), necessário para tratamento oncológico.
2. Segundo a jurisprudência do STJ, "é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental" (AgInt no AREsp 1.653.706/SP, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020; AgInt no AREsp 1.677.613/SP, Terceira Turma, julgado em 28/09/2020, DJe 07/10/2020; AgInt no REsp 1.680.415/CE, Quarta Turma, julgado em 31/08/2020, DJe 11/09/2020; AgInt no AREsp 1.536.948/SP, Quarta Turma, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020), especialmente na hipótese em que se mostra imprescindível à conservação da vida e saúde do beneficiário
3. Considera-se abusiva a negativa de cobertura de antineoplásicos orais. Precedentes.
4. A negativa administrativa ilegítima de cobertura para tratamento médico por parte da operadora de saúde só enseja danos morais na hipótese de agravamento da condição de dor, abalo psicológico e demais prejuízos à saúde já fragilizada do paciente. Precedentes.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.030.294/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022.)

No presente caso, o referido remédio se encontra registrado na Anvisa.

Ainda sobre a matéria discutida nos presentes autos, a jurisprudência daquela corte reconhece que a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS é **desimportante** quando se tratar da análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução normativa.

Vejam-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. ***PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA. NÃO OCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA*** *DE COBERTURA. MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. TRATAMENTO DE CÂNCER. RECUSA ABUSIVA. ROL DA ANS. NATUREZA. IRRELEVÂNCIA. CUSTEIO. OPERADORA.*
HIPÓTESES. USO DOMICILIAR OU AMBULATORIAL. RESTRIÇÕES.
1. Discute-se nos autos acerca da obrigatoriedade de cobertura pelo plano de saúde de medicamento indicado ao beneficiário para tratamento de câncer.
2. A decisão monocrática do relator não viola o princípio da colegialidade, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo interno.
3. É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim.
4. É obrigatório o custeio pelo plano de saúde de medicamento antineoplásico para tratamento de câncer, sendo irrelevante o questionamento acerca da natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS.
5. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a operadora de plano de saúde deve ofertar fármaco antineoplásico oral registrado na Anvisa, ainda que se trate de medicamento off-label.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 2.083.955/PB, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.)

Sobre o tema ainda em enfoque, confiram-se os julgados abaixo, que adotam orientação semelhante:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO. PACIENTE EM TRATAMENTO DE CÂNCER.
MEDICAMENTO OFF LABEL. RECUSA ABUSIVA. PRECEDENTES DO STJ.

INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Por ocasião do julgamento do REsp 1.733.013/PR, "fez-se expressa ressalva de que a natureza taxativa ou exemplificativa do aludido rol seria desimportante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução da ANS" (AgInt no REsp 1.949.270/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe de 24/02/2022).

2. No caso, trata-se de fornecimento de medicamento para tratamento de câncer, hipótese em que a jurisprudência é assente no sentido de que o fornecimento é obrigatório. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.911.407/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe de 24/05/2021; AgInt no AREsp 1.002.710/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe de 07/05/2020; AgInt no AREsp 1.584.526/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe de 17/03/2020.

3. Ademais, "Afigura-se abusiva a exclusão do custeio do tratamento consistente no uso off label de medicamento, o qual era imprescindível à conservação da vida e saúde do beneficiário" (AgInt no REsp 1.680.415/CE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 31/8/2020, DJe de 11/9/2020).

4. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso encontra óbice na Súmula 83/STJ.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.998.637/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 8/9/2022.)

Nesse ponto, importa destacar que a Segunda Seção, quando do julgamento dos EREsps n. 1.889.704/SP e 1.886.929/SP, embora tenha firmado entendimento no sentido de que o rol da ANS não pode ser considerado meramente exemplificativo, ressalvou expressamente, o fornecimento dos medicamentos relacionados ao tratamento de câncer.

Confira-se, a propósito, o seguinte trecho do voto proferido pelo Em. Ministro Relator:

Todavia, penso que não se devem generalizar e confundir as circunstâncias/situações.

É oportuno salientar a ponderação acerca do rol da ANS feita pela magistrada Ana Carolina Morozowski, especialista em saúde suplementar, em seminário realizado no STJ (2º Seminário Jurídico de Seguros) em 20 de novembro de 2019, in verbis:

"Por outro lado, há categorias de produtos (medicamentos) que não precisam estar previstas no rol - e de fato não estão. Para essas categorias, não faz sentido perquirir acerca da taxatividade ou da

exemplaridade do rol. As categorias são:

a) medicamentos relacionados ao tratamento do câncer de uso ambulatorial ou hospitalar; e b) medicamentos administrados durante internação hospitalar, o que não se confunde com uso ambulatorial. As tecnologias do item 'a' não se submetem ao rol, uma vez que não há nenhum medicamento dessa categoria nele, nem em Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT). Existe apenas uma listagem de drogas oncológicas ambulatoriais ou hospitalares em Diretriz de Utilização da ANS, mas com o único fim de evidenciar o risco emetogênico que elas implicam, para que seja possível estabelecer qual o tratamento será utilizado contra essas reações (DUT 54, item 54.6) Não há, portanto, nada que autorizasse a conduta da seguradora para negar a cobertura solicitada, devendo, portanto, ser responsabilizada pelos danos morais ocasionados recorridos."

O tratamento foi prescrito visando a cura ou abrandamento de um câncer avassalador. Invoca-se o mesmo argumento utilizado linhas atrás, no sentido de que, se o plano de saúde possui cláusula de cobertura da enfermidade, deve cobrir os demais procedimentos dela decorrentes (cirurgias, exames, uso de medicamentos, etc.), não podendo se negar à autorização. É o que ocorre no presente caso.

A recusa injustificada/abusiva da seguradora em cobrir o tratamento de saúde necessitado pelo paciente enseja reparação a título de dano moral. A jurisprudência pátria é quase unânime neste sentido. Inclusive, o STJ possui o entendimento pacificado de que a recusa ilegítima do plano de saúde ao tratamento indispensável ao restabelecimento da saúde do segurado frustrou a sua justa expectativa, aumentando o grau de aflição, angústia e dor suportados pelo paciente e aqueles que estavam a seu redor, de modo que a reparação por danos morais se impõe.

A fixação do valor indenitário, por seu turno, deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de atentar-se para a capacidade econômica da vítima e da parte contrária, para extensão da lesão provocada e para o caráter pedagógico-punitivo da indenização em foco, a fim de que, mediante a sua imposição, o ofensor não venha mais praticar atos lesivos. O magistrado deve evitar ainda o enriquecimento sem causa do lesionado e a ruína do praticante do ato ilícito. Considerando todos esses pressupostos, bem como, ainda, as circunstâncias advindas do caso concreto, fixo a quantia indenitária em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, **JULGO EXTINTO** o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, CPC, em relação à obrigação de fazer, diante da perda superveniente do objetivo, bem como, com base no artigo 487, inciso I, do CPC, resolvo **JULGAR PROCEDENTE** o pedido de condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com correção monetária a partir do arbitramento definitivo (S.362,STJ) e juros de mora a partir da data da citação.

Por fim, considerando o princípio da causalidade e diante da procedência, condeno a parte ré ao pagamento de honorários de 20% sobre o valor da condenação (artigo 85, §2º, do CPC). Ainda, condeno a ré ao pagamento das custas processuais.

Intimem-se.

Com o trânsito em julgado, certifique-se e, nada requerido, arquivem-se os autos.

Recife, 14 de março de 2025.

Carlos Eugênio de Castro Montenegro
Juiz de Direito

Assinado eletronicamente por: CARLOS EUGENIO DE CASTRO MONTENEGRO
14/03/2025 10:48:31
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 197755759

25031410483123800000192705397

IMPRIMIR GERAR PDF